内科含诊断 冠心病 ★★★（1~5 题）

中老年男性多见，高血脂尤其胆固醇、高血压、吸烟、糖尿病，胸骨后压榨性疼痛、可波及心前区、放射至左臂 / 颈部、伴大汗等			
	稳定型 / 劳力性心绞痛（2022）	不稳定型心绞痛、急性非 ST 段抬高型心梗（2007、2017、2022、2026）	急性 ST 段抬高型心梗（2010、2019、2021）
发病机制（2010）	稳定斑块（纤维帽厚 + 脂质少）致显著固定狭窄 无显著狭窄者：冠脉痉挛、微血管病变等	不稳定斑块破裂等继发血栓形成、栓塞、冠脉痉挛等 变异型心绞痛：冠脉自发严重痉挛	不稳定斑块破裂等继发血栓形成、栓塞、冠脉痉挛等
冠脉堵塞程度	不完全闭塞	不完全闭塞（变异型心绞痛完全闭塞）	完全闭塞
胸痛	明显诱因 多持续 3~5 分钟 频率、程度、持续时间等数个月内无明显变化	可休息发作：静息型和变异型（＜ 30 分钟）、NSTEMI（数小时）可能大 UA 发作频率高（2015、2017） 初发型：首发症状 1~2 个月内 CCS ≥III级（＜ 200m 或 1 层楼诱发） 恶化型：在稳定型心绞痛基础上逐渐加重（CCS 增加≥ Ⅰ级）	多休息发作 持续数小时甚至 1~2 天（2020） 发作频率低
休息或硝酸酯类	易缓解	暂时或不能完全缓解	几乎不缓解
血压	可增高		多下降（若正常可能有高血压病史等）
心肌坏死标志物	无	UA 无，NSTEMI 有	有，胸痛后 1~2 天可发热、中性粒细胞↑、血沉↑
发作时心电图	暂时性 ST 段压低≥ 0.1mV	UA：暂时性 ST 段压低≥ 0.1mV（变异型心绞痛 ST 段抬高，2026） NSTEMI：ST 段压低≥ 0.1mV 多＞ 12 小时	特征：病理 Q 波、ST 段弓背向上抬高、倒置 T 波 动态：高耸 T 波→ ST 段抬高→病理 Q 波→倒置 T 波
治疗	硝酸酯类 β-R 拮抗剂：伴高血压首选 CCB 伊伐布雷定 ACEI/ARB/ARNI：特别适合伴糖尿病、蛋白尿等 抗板：阿司匹林或吲哚布芬、替格瑞洛或氯吡格雷“2 个格格” 降脂：他汀类、依折麦布“一折卖不抑吸收” 药物无效行 PCI 等	变异型心绞痛：首选硝苯地平、不用 β-R 拮抗剂（2013、2017、2026） PCI 最佳：任意一条极高危者＜ 2 小时 （治疗无效、心源性休克、急性心衰、室颤、心搏骤停、心梗合并乳头肌断裂或心脏破裂、间歇性 ST 段抬高） 类似稳定型心绞痛，但注意： COX-1 抑制剂 +P2Y12 受体拮抗剂双联抗血小板＞ 1 年 （PCI 者加血小板 GP Ⅱ b/ Ⅲ a 受体拮抗剂替罗非班或阿昔单抗） 抗板基础上肝素抗凝（PCI 者加直接凝血酶抑制剂比伐卢定）	缓解疼痛：再灌注治疗、β-R 拮抗剂、吗啡 / 哌替啶、硝酸酯类 再灌注治疗： 3~6 小时、最多 12 小时内 直接 PCI 最佳（2014） 预计直接 PCI ＞ 2 小时→溶栓（2010） ①禁忌症：脑卒中、骨折、大手术、主动脉夹层、高血压 3 级、不能压迫部位大血管穿刺 ②再通标准：冠脉造影，CK-MB 高峰提前出现、抬高 ST 段 2 小时内回降＞ 50%、 胸痛 2 小时内基本消失、2 小时内再灌注心律失常（加速性室性自主心律等） “2222+14 又可以打扑克了” PCI、溶栓无效→ 6~8 小时内冠脉旁路移植 其他治疗类似 UA/NSTEMI（2008、2017）